Le Cercle
des Généralistes
Le média de référence des médecins généralistes

Revue hebdomadaire
lecercledesgeneralistes.fr

Revue du 13 octobre 2026

La rédaction du Cercle des Généralistes · 34 min de lecture

La Cour des comptes veut obliger chaque généraliste libéral installé à suivre un minimum de patients comme médecin traitant, 500 selon sa piste. Nous avons regardé pourquoi la Cour en arrive là, qui est réellement visé, ce que rapporterait ce seuil, et pourquoi un quota serait une mauvaise réponse pour les médecins. L'ANSM demande de limiter les nouveaux traitements par furosémide et par duloxétine, alors que plusieurs relais possibles de la duloxétine, dont la fluoxétine 20 mg et la venlafaxine LP, sont eux-mêmes en tension. Depuis le 1er octobre, la case « ALD non exonérante » ne se coche plus sur un bon de transport, sauf pour certains mineurs. Enfin, l'ANSM alerte sur le mésusage et les interactions des aGLP-1, et sur un risque d'atteinte hépatique grave sous Ocrevus.

Au sommaire de la semaine

Médecin traitant : la Cour des comptes veut imposer un minimum de patients à chaque généraliste **2**

Furosémide 20 et 40 mg, duloxétine : l'ANSM demande de limiter les nouveaux traitements **8**

Bon de transport : ne cochez plus la case ALD non exonérante, sauf pour certains mineurs **11**

Ozempic, Wegovy, Mounjaro : mésusage pour maigrir, pancréatites et interactions, le 3e bilan de l'ANSM **14**

Ocrevus (sclérose en plaques) : risque hépatique grave, bilan avant le traitement et la 2e perfusion **16**

Médecin traitant : la Cour des comptes veut imposer un minimum de patients à chaque généraliste

SITUATION

La Cour des comptes veut obliger chaque généraliste libéral installé à suivre un minimum de patients comme médecin traitant, 500 selon sa piste.

Son rapport « Le dispositif du médecin traitant. Une ambition partagée à mieux soutenir », demandé par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, a été rendu public le 30 septembre 2026. Le 6 octobre 2026, le député Guillaume Garot a déposé une proposition de loi qui retient, elle, une part d'au moins 30 % de la patientèle. Rien de tout cela ne s'applique aujourd'hui : il faudrait une négociation conventionnelle ou une loi.

CONTEXTE

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a saisi la Cour le 8 juillet 2025, pour un bilan du dispositif 20 ans après sa création et des pistes « en vue de renforcer l'accès aux soins des patients ». La Cour précise que son rapport n'évalue pas ses résultats en matière de santé publique ni de maîtrise médicalisée de la dépense.

Pourquoi la Cour en arrive à un seuil : son constat de départ est démographique. Selon elle, « à court terme, la démographie médicale entraîne une érosion du vivier de médecins traitants ». 50 % seulement des 100 000 médecins généralistes en exercice en 2024 ont une activité de médecin traitant. D'après la CNAM, le nombre de généralistes libéraux médecins traitants a baissé d'environ 4 % entre 2016 et 2023. Les nouvelles installations ne compensent pas les départs. La génération qui assure le plus souvent cette mission approche de la retraite, et la suivante l'exerce moins souvent. Le nombre moyen de jours travaillés par un généraliste est passé de 239 en 2016 à 216 en 2023. Les généralistes partent aussi vers d'autres exercices : salariat, exercice mixte, remplacement, centres de soins non programmés, passés de quelques dizaines en 2018 à près de 600.

Du côté des patients, au 30 juin 2025, 48,7 millions d'assurés, soit 88,5 % de la population adulte, avaient déclaré un médecin traitant ; 6,3 millions n'en avaient pas. Selon la Drees, citée par la Cour, 2 généralistes sur 3 déclaraient en 2022 refuser de nouveaux patients comme médecin traitant, contre 53 % en 2019. En 2023, 1 patient sans médecin traitant sur 3 l'était après la cessation d'activité de son ancien médecin. Pour la Cour, l'absence de médecin traitant relèverait pourtant, pour la plus grande part, d'une « situation choisie » : seuls 40 % des 6,3 millions d'assurés sans médecin traitant se voient appliquer les pénalités de remboursement. 1 assuré sans médecin traitant sur 4 reçoit de sa caisse un « médecin traitant fictif » pour éviter un renoncement aux soins, ce que la Cour lit comme « la reconnaissance des difficultés d'accès au médecin traitant ».

À long terme, la Cour juge la tendance plus favorable, avec l'arrivée des étudiants formés depuis la fin du numerus clausus : selon les projections de la Drees qu'elle cite, la densité de généralistes progresserait de 15 % entre 2025 et 2040.

Un seuil de patientèle existe déjà dans la convention : selon la Cour, l'aide à l'embauche d'un assistant médical exige une patientèle au moins égale au 30e percentile de la distribution nationale.

Le rapport rappelle aussi qu'un généraliste suit en moyenne 2 200 patients au Royaume-Uni, et que l'Italie plafonne la patientèle à 1 500.

Le rapport a été largement repris. Egora a titré le 30 septembre « Médecin traitant : un rapport de la Cour des comptes recommande d'imposer un minimum de 500 patients par généraliste ». Le même jour, Le Quotidien du Médecin titrait « Médecins traitants : 8 553 généralistes libéraux dans le viseur de la Cour des comptes ». Que Choisir a écrit le 3 octobre que le rapport « préconise de fixer un seuil minimal de 500 patients suivis par médecin ». Parmi les articles que nous avons pu lire, celui de Vidal, tiré d'une dépêche de l'APM, est le seul à préciser que ce seuil « pourrait être » de 500 patients, et qu'il serait modulé.

La proposition de loi n° 3264, « assurant l'accès à un médecin traitant pour chaque patient », a été renvoyée à la commission des affaires sociales.

CE QUI EST CONFIRMÉ

Sur les 53 840 médecins généralistes libéraux recensés en 2024, 8 553 n'exercent pas de missions de médecin traitant ou le font pour une faible patientèle, sous le seuil de 200 patients médecin traitant vus dans l'année. La Cour ne compte que les patients de 16 ans et plus. Sur le champ de son étude, 53 183 médecins, elle compte 44 630 médecins traitants, 6 892 médecins à faible patientèle et 1 661 médecins qu'aucun patient n'a déclarés comme médecin traitant. S'y ajoutent 5 533 médecins généralistes des centres de santé, soit un peu plus de 50 000 médecins traitants.

Selon le tableau 14 du rapport, les 8 553 médecins peu ou pas médecins traitants exercent pour 75 % dans les grands centres urbains, contre 50 % des médecins traitants, et pour 65 % dans les communes où l'accessibilité aux généralistes est la plus élevée. 17 % exercent en zone d'intervention prioritaire, contre 25 % des médecins traitants, et 40 % hors des zones d'intervention prioritaire et d'action complémentaire, contre 30 %. 21 % ont un mode d'exercice particulier, notamment la médecine d'urgence, SOS Médecins, l'acupuncture ou l'homéopathie ; 12 % ont 70 ans ou plus, et 18 % ont commencé leur activité libérale en 2023 ou en 2024. 86 % sont en secteur 1, contre 97 % des médecins traitants ; 6 % sont en secteur 2 hors Optam et 3 % en secteur 3.

Recommandation n° 2 de la Cour : « Rendre obligatoire, dans le cadre des prochaines négociations conventionnelles, un seuil minimal de patientèle prise en charge en tant que médecin traitant, pour tout médecin généraliste libéral installé (CNAM) ». Le seuil de 500 patients, retenu par la CNAM comme seuil d'une activité significative de médecin traitant, « pourrait être envisagé ». Il conduirait à 300 à 500 patients médecin traitant de plus pour les médecins concernés, soit un potentiel de 2,5 à 4 millions de patients. Selon la Cour, un seuil uniforme pourrait avoir des effets contre-productifs dans certaines situations ; elle propose de le moduler selon le mode d'exercice, la quotité de travail, l'ancienneté d'installation, la structure de patientèle (âgée, en ALD, précaire) ou les missions universitaires ou territoriales.

96 % des patients en ALD ont déclaré un médecin traitant, contre 83 % des 5,4 millions de bénéficiaires de la C2S, des assurés précaires dont la couverture s'est fortement dégradée depuis 2019. La Cour recense encore 575 000 patients en ALD sans médecin traitant, et environ 850 000 bénéficiaires de la C2S dans la même situation. En 2023, plus de 20 % des patients qui avaient un généraliste libéral pour médecin traitant ne l'avaient pas vu dans l'année. Rapporté à la population, cela représenterait près de 11 millions d'assurés, selon la Cour.

Depuis le 1er janvier 2026, le forfait médecin traitant remplace le forfait patientèle et la rémunération sur objectifs de santé publique. Selon l'Assurance Maladie, son socle annuel par patient est de 5 € de 7 à 74 ans sans ALD, de 15 € avant 7 ans et de 75 à 79 ans, de 55 € à partir de 80 ans ou en ALD avant 80 ans, et de 100 € en ALD à partir de 80 ans, avec 10 € de plus pour un bénéficiaire de la C2S. Un patient qui n'a fait l'objet d'aucun acte facturé par le médecin ou son collaborateur dans les 2 années précédant la date du constat ne rapporte que 5 €. Le forfait est réservé aux médecins de secteur 1 et aux médecins de secteur 2 adhérents de l'Optam ou de l'Optam-ACO.

Selon la Cour, le forfait patientèle médecin traitant et la rémunération sur objectifs de santé publique ont représenté plus de 1,2 Md€ en 2024. Pour un généraliste libéral sans mode d'exercice particulier, ils représentaient en moyenne 23 400 € par an : 18 000 € de forfait et 5 400 € de rémunération sur objectifs. Le paiement à l'acte compte pour près de 80 % de la rémunération des généralistes libéraux. Selon la Cour, environ 15 % des généralistes libéraux médecins traitants emploient un assistant médical ; leur patientèle médecin traitant augmente de 19,5 % au bout de 4 ans, et l'aide à l'emploi a représenté 99 M€ en 2025 pour les généralistes libéraux. Les médecins exerçant en maison de santé pluriprofessionnelle refusent en moyenne moins de nouveaux patients comme médecin traitant. Les 7 autres recommandations portent sur les systèmes d'information, la couverture des publics vulnérables, les aides aux CPTS, l'enseignement du 2e cycle des études médicales, les outils numériques du médecin traitant, la part forfaitaire de la rémunération et les financements collectifs des MSP et des centres de santé.

La proposition de loi confie à la convention médicale la fixation d'une « fraction minimale de patients » qui ont désigné le médecin comme médecin traitant. Cette fraction ne peut être inférieure à 30 % de la patientèle ; elle est adaptée notamment à la quotité de travail, à l'ancienneté d'installation, aux caractéristiques de la patientèle et aux conditions d'exercice sur le territoire. Si aucune mesure n'est prise dans les 12 mois suivant la promulgation, le ministre chargé de la Santé la fixe après avis de la Haute Autorité de santé et du Conseil national de l'Ordre des médecins. Son article 2 interdit, dans le cadre d'une consultation ou d'une téléconsultation, toute prestation complémentaire payante visant à faciliter l'accès à une consultation, à un acte ou à un examen, en contrepartie d'un rendez-vous obtenu plus vite ou d'un accès facilité à un professionnel de santé.

CE QUI POSE QUESTION

Au 13 octobre 2026, 5 questions restent ouvertes. Le seuil se compterait-il en patients déclarés ou en patients vus ? Le rapport ne le dit pas, alors qu'il classe lui-même les médecins sur les patients vus dans l'année, et que près de 11 millions d'assurés n'ont pas vu leur médecin traitant dans l'année.

Les enfants compteraient-ils ? La Cour ne retient que les patients de 16 ans et plus, alors que le forfait médecin traitant couvre aussi les enfants.

Combien de généralistes suivent entre 200 et 500 patients médecin traitant ? Un seuil de 500 les placerait aussi en dessous, mais le rapport ne compte que ceux qui en suivent moins de 200, et son potentiel de 2,5 à 4 millions de patients ne porte que sur ces 8 553 médecins.

Que risquerait un médecin sous le seuil ? Ni le rapport ni la proposition de loi ne prévoient de conséquence : la proposition de loi renvoie les modalités à la convention.

Quand, et par quel chemin ? La Cour renvoie aux « prochaines négociations conventionnelles », sans date, alors que la convention en vigueur a été signée le 4 juin 2024. Le site de l'Assemblée nationale

n'affiche ni rapporteur ni date d'examen pour la proposition de loi, et le rapport ne publie ni la réponse de la CNAM ni celle du ministère de la Santé.

L'IMPACT FINANCIER & ORGANISATIONNEL

La Cour chiffre l'effort à 300 à 500 patients médecin traitant de plus pour chaque médecin concerné. Calcul du Cercle sur la grille de l'Assurance Maladie : 300 patients de 7 à 74 ans sans ALD rapportent 1 500 € de forfait socle par an ; 300 patients en ALD de moins de 80 ans, 16 500 €. Les majorations de prévention, à 5 € par indicateur validé, et les consultations s'y ajoutent. Pour un médecin de secteur 2 hors Optam ou de secteur 3, le forfait est nul.

Chez un médecin traitant, chaque patient en ALD de moins de 80 ans sans acte facturé depuis 2 ans fait perdre 50 € de forfait par an (5 € au lieu de 55 €), et 95 € à partir de 80 ans (5 € au lieu de 100 €).

L'effort, lui, porte sur le suivi. Selon la Cour, un médecin traitant libéral suivait en moyenne 1 130 patients à ce titre en 2024, contre 919 en 2016, et les patients en ALD, de plus de 65 ans ou bénéficiaires de la C2S représentent en moyenne 56 % de son activité. Toujours selon la Cour, toutes choses égales par ailleurs, le poids du forfait médecin traitant ne passerait que de 11,8 % de la rémunération en 2024 à 13 % en 2028.

LE REGARD DU CERCLE

Un quota de patients est une mauvaise réponse, et ce sont les médecins qui la paieraient. D'abord parce qu'il fait porter aux généralistes installés une pénurie qu'ils n'ont pas créée : pendant des décennies, le numerus clausus a limité le nombre de médecins formés, jusqu'à la loi du 24 juillet 2019, et la Cour n'attend ses effets qu'à long terme. Un seuil ne crée pas de temps médical : il répartit l'effort entre ceux qui sont déjà là, ce que la Cour appelle elle-même « une meilleure répartition de l'effort de prise en charge ».

Ensuite parce qu'il frapperait d'abord les plus jeunes et ceux qui font autre chose d'utile. 33 % des 8 553 médecins visés ont 39 ans ou moins, et 18 % ont commencé leur activité libérale en 2023 ou en 2024. La Cour écrit pourtant que l'amélioration attendue suppose que « ne se dégrade pas davantage l'attractivité du dispositif vis-à-vis des jeunes médecins » : une contrainte de plus à l'installation pousserait vers le salariat ou le remplacement, les exercices qui vident déjà le vivier. Et 1 sur 4 de ces médecins voit déjà plus de 2 944 patients dans l'année, sans les suivre comme médecin traitant : leur imposer 500 patients suivis au long cours, c'est retirer du temps aux consultations ponctuelles qu'ils assurent.

Enfin parce qu'il change la règle du jeu, et qu'il paierait mal. La convention incitait ; le seuil imposerait, et la proposition de loi prévoit qu'à défaut d'accord dans les 12 mois, le ministre le fixe lui-même, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Ordre. À 5 € par an pour un patient de 7 à 74 ans sans ALD, le forfait ne paie pas le suivi qu'on demanderait, et il ne paie rien aux médecins de secteur 2 hors Optam ou de secteur 3.

Ce que la presse a manqué, c'est la cible. Elle a retenu un chiffre, 500, et une idée, l'obligation, alors que le rapport présente le seuil comme une piste à moduler. Ses propres tableaux montrent des médecins qu'on imagine mal : 3 sur 4 exercent dans les grands centres urbains, 40 % hors des zones d'intervention prioritaire et d'action complémentaire, contre 30 % des médecins traitants. Cité par Egora le 30 septembre, Bernard Lejeune, président de la 6e chambre de la Cour, les a décrits comme exerçant « majoritairement en secteur 2 ». Le tableau 14 de son rapport en compte 86 % en secteur 1.

Les leviers qui augmentent vraiment la capacité de suivi sont dans le rapport lui-même : l'assistant médical, l'exercice en maison de santé, et un forfait qui paie le suivi plutôt que la déclaration. L'Assurance Maladie le fait déjà en partie : un patient non vu depuis 2 ans ne rapporte que 5 €. Un seuil compté en patients déclarés irait à rebours, et fabriquerait des médecins traitants de papier, quand près de 11 millions d'assurés ne voient déjà pas le leur.

RECOMMANDATIONS

- **Généraliste libéral qui suit peu de patients comme médecin traitant** : Compter avec son logiciel ses patients médecin traitant de 16 ans et plus vus dans l'année, et faire confirmer le chiffre par sa CPAM : sous 200, il relève de la catégorie des 8 553 médecins recensés en 2024 ; entre 200 et 500, il serait sous le seuil envisagé, sans figurer parmi les médecins que chiffre la Cour. Puis transmettre à son syndicat les critères de modulation qui le concernent : mode d'exercice, temps partiel, installation récente, patientèle, missions universitaires ou territoriales.

- **Médecin traitant qui a des patients déclarés perdus de vue** : Repérer les patients qui l'ont déclaré et pour lesquels ni lui ni son collaborateur n'a facturé d'acte depuis 2 ans, en commençant par ceux en ALD, puis leur proposer une consultation de suivi : sans acte sur 2 ans, leur forfait tombe à 5 € par an, au lieu de 55 € ou de 100 €.
- **Médecin traitant qui refuse de nouveaux patients faute de temps** : Demander à sa CPAM les conditions de l'aide à l'emploi d'un assistant médical, avec lequel, selon la Cour, la patientèle médecin traitant augmente de 19,5 % au bout de 4 ans, et étudier l'exercice en maison de santé pluriprofessionnelle, où les médecins refusent moins de nouveaux patients.

Sources

Cour des comptes, Le dispositif du médecin traitant. Une ambition partagée à mieux soutenir (septembre 2026)

Assemblée nationale, proposition de loi n° 3264 assurant l'accès à un médecin traitant pour chaque patient

Assemblée nationale, dossier législatif de la proposition de loi n° 3264

Assurance Maladie, le nouveau forfait médecin traitant (page du 16 juin 2026)

Egora, « Médecin traitant : un rapport de la Cour des comptes recommande d'imposer un minimum de 500 patients par généraliste » (30 septembre 2026)

Le Quotidien du Médecin, « Médecins traitants : 8 553 généralistes libéraux dans le viseur de la Cour des comptes » (30 septembre 2026)

Vidal, d'après une dépêche de l'APM, « Médecin traitant : la Cour des comptes préconise une patientèle minimale obligatoire pour les généralistes » (1er octobre 2026)

Que Choisir, « 6,3 millions de patients sans médecin traitant » (3 octobre 2026)

Traçabilité : Cour des comptes ; Assemblée nationale ; Assurance Maladie (ameli.fr). Les articles de presse, lus le 13 octobre 2026, sont cités pour la façon dont ils ont rendu compte du rapport, jamais comme source d'un fait.

Furosémide 20 et 40 mg, duloxétine : l'ANSM demande de limiter les nouveaux traitements

SITUATION

L'ANSM demande de limiter les nouveaux traitements par furosémide 20 et 40 mg et par duloxétine 30 et 60 mg, et de privilégier une alternative si possible.

L'ANSM a publié le 6 octobre 2026 un point de situation sur le furosémide, et le 9 octobre 2026 une actualité sur la duloxétine, mise à jour le 12 octobre 2026.

CONTEXTE

Le furosémide 20 mg et 40 mg en comprimés connaît de fortes tensions d'approvisionnement, liées à des difficultés de production chez Viatris et Zentiva. D'autres laboratoires compensent depuis plusieurs mois le déficit de Viatris. Selon la fiche de disponibilité de l'ANSM, publiée le 21 septembre 2026 et mise à jour le 28 septembre 2026, la tension touche la ville depuis le 1er septembre 2026, pas l'hôpital.

La duloxétine 30 mg et 60 mg, en gélule gastro-résistante, est indiquée dans les épisodes dépressifs majeurs, le trouble anxieux généralisé et certaines douleurs neuropathiques, notamment chez les personnes diabétiques. Ses difficultés d'approvisionnement tiennent à des problèmes temporaires de production. L'avis de tension a été publié le 18 septembre 2026 et mis à jour le 9 octobre 2026.

CE QUI EST CONFIRMÉ

Pour le furosémide, l'approvisionnement de Viatris ne devrait pas revenir à la normale avant avril 2027. Chez Zentiva, les difficultés sont temporaires, mais aucune date de retour n'est connue. L'ANSM a demandé aux autres laboratoires de mettre à disposition le maximum de boîtes, y compris leurs stocks de sécurité, et de limiter les ventes directes aux pharmacies au profit des grossistes-répartiteurs. Les laboratoires concernés doivent rechercher des possibilités d'importation de médicaments équivalents, et les grossistes-répartiteurs n'ont plus le droit de l'exporter. L'ANSM publiera les dates de retour dès que les laboratoires les lui transmettront.

Pour les prescripteurs, l'ANSM demande de limiter les nouveaux traitements par furosémide, de réévaluer au renouvellement la nécessité de le poursuivre et, quand c'est possible, de privilégier un autre diurétique, sans en nommer aucun. Selon sa fiche de disponibilité, le bumétanide (Burinex 1 mg et 5 mg, comprimés), autre diurétique de l'anse, est remis à disposition normale depuis le 5 août 2026, date de la dernière mise à jour de sa fiche, qui le présente en 2e ligne dans l'insuffisance cardiaque.

Pour la duloxétine, les laboratoires prévoient un retour à la normale progressif dans les pharmacies à partir de mi-novembre 2026. Ils doivent mettre en circulation le maximum de boîtes, y compris leurs stocks de sécurité, et approvisionner les pharmacies par les grossistes-répartiteurs plutôt qu'en vente directe. Une interdiction d'exporter est en vigueur depuis mi-septembre 2026, et l'ANSM étudie d'autres mesures.

Pour les prescripteurs, l'ANSM demande de limiter les nouveaux traitements par duloxétine jusqu'au retour à la normale. Dans l'épisode dépressif majeur ou le trouble anxieux généralisé, elle recommande de privilégier un autre antidépresseur, notamment un ISRS ou un IRSNa ; dans la douleur neuropathique diabétique, les gabapentinoïdes ou les antidépresseurs tricycliques. Les

patients déjà traités ne doivent pas arrêter brutalement ; en cas d'indisponibilité, ils contactent leur médecin, qui organisera si nécessaire un relais adapté.

Plusieurs de ces relais possibles sont eux-mêmes en tension, selon les fiches de disponibilité de l'ANSM consultées le 13 octobre 2026. La fluoxétine 20 mg (ISRS) l'est depuis le 2 septembre 2026, en ville et à l'hôpital. La venlafaxine LP 37,5 mg et LP 75 mg (IRSNa) l'est depuis le 20 mars 2025, et sa fiche, mise à jour le 13 avril 2026, prévoit une remise à disposition normale « courant 2026 ». Chez les tricycliques, la Clomipramine Viatris 25 mg l'est depuis le 4 juillet 2025, et le Tofranil 10 mg (imipramine) depuis le 31 juillet 2022, avec une remise à disposition prévue à l'été 2027 ; ces 2 spécialités sont contingentées en ville.

Pour la fluoxétine, l'ANSM a annoncé le 25 septembre 2026, dans un point de situation, une normalisation de la disponibilité en pharmacie prévue pour la mi-octobre. D'ici là, les initiations doivent être réservées en priorité aux épisodes dépressifs de l'enfant à partir de 8 ans et de l'adolescent, afin de permettre la continuité de traitement des patients déjà traités.

CE QUI POSE QUESTION

Au 13 octobre 2026, 4 questions restent ouvertes. Le bumétanide tiendra-t-il si les prescriptions de furosémide s'y reportent ? L'ANSM ne dit rien de ses stocks face à un report.

Quand Zentiva retrouvera-t-il un approvisionnement normal, et quelles importations seront mises en place ? Aucune date n'est donnée.

Pour la duloxétine, quelles « autres mesures » l'ANSM étudie-t-elle, et le retour annoncé à partir de mi-novembre sera-t-il effectif dans toutes les pharmacies ?

La fluoxétine 20 mg sera-t-elle bien revenue en pharmacie à la mi-octobre ? Au 13 octobre, sa fiche de disponibilité la signale toujours en tension, et le point de situation du 25 septembre n'a pas été mis à jour.

L'IMPACT FINANCIER & ORGANISATIONNEL

Aucun impact financier direct pour le cabinet n'est annoncé. La charge est organisationnelle, et elle n'a pas la même durée pour les 2 molécules : quelques semaines pour la duloxétine, au moins jusqu'en avril 2027 pour une partie de l'offre de furosémide.

Les ordonnances non honorées en pharmacie vont générer des appels et des consultations de relais, et chaque renouvellement de furosémide devient un moment de réévaluation. Pour la duloxétine, un relais mal choisi peut tomber sur une 2e tension : la vérification de disponibilité fait désormais partie de la prescription.

LE REGARD DU CERCLE

La consigne de l'ANSM sur la duloxétine a un angle mort : parmi les relais possibles, la fluoxétine 20 mg, la venlafaxine LP 37,5 et 75 mg, la Clomipramine Viatris 25 mg et le Tofranil 10 mg sont eux-mêmes en tension, et, jusqu'au retour annoncé pour la mi-octobre, les nouveaux traitements par fluoxétine sont réservés en priorité aux épisodes dépressifs de l'enfant et de l'adolescent. Changer de molécule sans vérifier, c'est risquer un 2e relais quelques semaines plus tard.

Pour le furosémide, la consigne est plus délicate. Chez l'insuffisant cardiaque, un diurétique de l'anse ne se remplace pas à la légère. Le bumétanide est remis à disposition depuis le 5 août, mais sa fiche le situe en 2e ligne dans l'insuffisance cardiaque, et un report massif pourrait le mettre à son tour en tension : mieux vaut le réserver aux patients qui ont vraiment besoin d'un diurétique de l'anse, et commencer la réévaluation par les prescriptions dont l'indication n'est plus claire.

Pour la duloxétine, l'ANSM rappelle de ne pas arrêter brutalement : un patient qui ne trouve plus sa boîte doit appeler son médecin avant d'arrêter. Le même réflexe vaut pour le furosémide, même si l'ANSM ne donne pas de consigne aux patients.

RECOMMANDATIONS

- **Médecin qui prescrit du furosémide 20 ou 40 mg** : Limiter les nouveaux traitements et, à chaque renouvellement, réévaluer la poursuite, en envisageant le bumétanide, remis à disposition le 5 août 2026 et de 2e ligne dans l'insuffisance cardiaque selon sa fiche, quand un diurétique de l'anse reste nécessaire et que le furosémide manque.
- **Médecin qui initie ou suit un traitement par duloxétine** : Pour un nouveau patient, privilégier une alternative (ISRS ou IRSNa dans la dépression et le trouble anxieux généralisé, gabapentinoïde ou tricyclique dans la douleur neuropathique diabétique) dont la disponibilité a été vérifiée sur le site de l'ANSM. Pour un patient déjà traité, ne prévoir un relais que si la duloxétine manque en pharmacie, et lui rappeler de ne pas arrêter brutalement.

Sources

ANSM, point de situation sur les tensions en furosémide 20 mg et 40 mg comprimés (6 octobre 2026)

ANSM, disponibilité des spécialités à base de furosémide 20 mg et 40 mg en comprimés

ANSM, disponibilité de Burinex 1 mg et 5 mg, comprimé (bumétanide)

ANSM, duloxétine : l'ANSM demande aux laboratoires de renforcer leurs approvisionnements (9 octobre 2026, mis à jour le 12 octobre 2026)

ANSM, point de situation sur les tensions en fluoxétine 20 mg (25 septembre 2026)

ANSM, disponibilité des spécialités à base de fluoxétine 20 mg

ANSM, disponibilité des spécialités à base de venlafaxine LP 37,5 mg et LP 75 mg

ANSM, disponibilité de Clomipramine Viatris 25 mg, comprimé pelliculé

ANSM, disponibilité de Tofranil 10 mg, comprimé enrobé (imipramine)

Traçabilité : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), actualités et fiches de disponibilité consultées le 13 octobre 2026

Bon de transport : ne cochez plus la case ALD non exonérante, sauf pour certains mineurs

SITUATION

Depuis le 1er octobre 2026, une ALD non exonérante n'ouvre plus de prise en charge des transports : la case ne doit plus être cochée, sauf exception.

L'Assurance Maladie l'a annoncé le 30 septembre 2026. La mesure applique le décret n° 2026-812 du 21 août 2026 aux transports prescrits à partir du 1er octobre 2026.

CONTEXTE

Le décret n° 2026-812 du 21 août 2026 supprime le motif de prise en charge des transports lié aux affections de longue durée dites « non exonérantes », c'est-à-dire non prises en charge à 100 %. Ces affections sont aussi visées par la réduction de la durée d'indemnisation des arrêts de travail (voir notre article sur la durée dérogatoire des arrêts de travail).

Le formulaire de prescription médicale de transport et le service en ligne vont être mis à jour.

CE QUI EST CONFIRMÉ

Pour les transports prescrits depuis le 1er octobre 2026, la case « ALD non exonérante » ne doit plus être cochée sur la prescription médicale de transport, sauf dans la situation prévue pour les mineurs. Les formulaires actuels restent utilisables pendant une période transitoire.

La prise en charge est maintenue pour les mineurs dont l'état de santé nécessite des soins continus de plus de 6 mois, reconnus par le service médical de l'Assurance Maladie et correspondant à une déficience ou une incapacité définie par le référentiel de prescription. Sont notamment visés les trajets vers des séances chez des professionnels de santé conventionnés, psychologues, orthophonistes ou masseurs-kinésithérapeutes, pour des enfants en situation de handicap, en cours de reconnaissance de handicap ou accidentés.

Dans cette situation, le médecin coche la case « ALD non exonérante » et écrit dans le champ « éléments d'ordre médical » : « Mineur nécessitant des soins prolongés en raison d'un handicap, d'une incapacité ou d'un accident ». Cette mention vaut en attendant un formulaire doté d'une case dédiée.

Les transports des enfants en situation de handicap pris en charge en CAMSP ou en CMPP restent pris en charge au titre de ce motif, pour les soins dans ces structures comme pour les séances en ville avec les professionnels qui interviennent dans leur parcours.

Selon la page de l'Assurance Maladie sur la prescription des transports, mise à jour le 30 septembre 2026, les transports restent pris en charge dans 7 situations : une hospitalisation, en entrée ou en sortie ; une ALD, si le transport est en lien avec elle et que le patient présente une incapacité ou une déficience du référentiel ; un accident du travail ou une maladie professionnelle ; un état qui impose l'ambulance, allongé ou sous surveillance ; un trajet de plus de 150 km aller, avec accord préalable ; des transports en série, au moins 4 transports de plus de 50 km aller sur 2 mois pour un même traitement, avec accord préalable ; des soins en CAMSP ou en CMPP, avec accord préalable. La page ajoute les déplacements sur convocation du service médical, de la commission régionale d'invalidité, d'un médecin expert ou d'un fournisseur d'appareillage, et la prise en charge d'un

accompagnant pour un enfant de moins de 16 ans ou une personne qui a besoin d'un tiers. En dehors de ces situations, « les transports ne sont pas du tout pris en charge ».

CE QUI POSE QUESTION

Au 13 octobre 2026, 2 questions restent ouvertes. Combien de temps durera la période transitoire, et quand le nouveau formulaire sera-t-il disponible ? L'Assurance Maladie ne donne aucune date.

Pour un enfant suivi en CAMSP ou en CMPP, faut-il aussi porter la mention prévue pour les mineurs ? L'actualité de l'Assurance Maladie du 30 septembre indique seulement que ces transports continueront à être pris en charge « au titre de ce motif ».

L'IMPACT FINANCIER & ORGANISATIONNEL

Pour les patients adultes concernés, les transports ne sont plus pris en charge par l'Assurance Maladie sous ce motif : certains découvriront un reste à charge, et la question reviendra en consultation.

Pour le cabinet, la règle change sur un formulaire déjà en circulation : il faut ne plus cocher une case qui reste imprimée, vérifier que le transport relève d'une des 7 situations restantes et, pour les mineurs concernés, recopier une mention exacte dans le champ médical, à la main ou dans le logiciel.

LE REGARD DU CERCLE

La mesure est une économie décidée par décret, mais elle se joue sur l'ordonnance du médecin : la case reste sur le formulaire, et c'est au prescripteur de ne plus la cocher et de l'expliquer au patient. L'Assurance Maladie a publié sa consigne la veille de l'entrée en vigueur.

L'exception pour les mineurs est bien pensée, mais elle repose, tant que le formulaire n'est pas à jour, sur une mention à recopier mot pour mot.

RECOMMANDATIONS

- **Médecin qui prescrit un transport pour un adulte** : Vérifier avant de signer que le transport relève d'une des 7 situations restantes (hospitalisation, ALD en lien avec le transport et incapacité ou déficience, accident du travail ou maladie professionnelle, ambulance, plus de 150 km, transports en série, CAMSP ou CMPP), et sinon prévenir le patient qu'il ne sera pas remboursé.
- **Médecin qui suit un mineur en soins continus de plus de 6 mois, reconnus par le service médical, pour une déficience ou une incapacité du référentiel** : Cocher la case et recopier dans le champ « éléments d'ordre médical » la mention « Mineur nécessitant des soins prolongés en raison d'un handicap, d'une incapacité ou d'un accident ».

Sources

Assurance Maladie, suppression de l'ALD non exonérante des motifs de prise en charge des transports (30 septembre 2026)

Assurance Maladie, prescription de transports (mise à jour le 30 septembre 2026)

Légifrance, décret n° 2026-812 du 21 août 2026

Service Public, arrêts maladie : baisse de la durée d'indemnisation de certains arrêts longs (24 septembre 2026)

Traçabilité : Assurance Maladie (ameli.fr) ; Légifrance ; Service Public

Ozempic, Wegovy, Mounjaro : mésusage pour maigrir, pancréatites et interactions, le 3e bilan de l'ANSM

SITUATION

Le 3e rapport de pharmacovigilance de l'ANSM sur les aGLP-1 relève un mésusage persistant pour maigrir et met en évidence des interactions médicamenteuses.

L'ANSM a publié ce rapport le 7 octobre 2026. Il analyse les effets indésirables des aGLP-1 déclarés entre février 2025 et janvier 2026.

CONTEXTE

Les aGLP-1 sont des médicaments utilisés pour traiter le diabète de type 2 et l'obésité. L'ANSM a mis en place une enquête de pharmacovigilance réalisée par les centres régionaux de pharmacovigilance. Ce rapport est le 3e.

Les médicaments suivis sont Trulicity, Ozempic, Victoza, Liraglutide SUN, Xultophy et Mounjaro dans le diabète de type 2 insuffisamment contrôlé. Wegovy, Mounjaro et Saxenda le sont dans le contrôle du poids en 2e intention.

Le rapport met en évidence la persistance de mésusages dangereux, notamment pour la perte de poids en dehors de tout cadre médical. Il met en évidence des interactions médicamenteuses et souligne le risque de carences nutritionnelles et de malnutrition. L'ANSM confirme le rapport bénéfice/risque favorable des aGLP-1 lorsqu'ils sont utilisés conformément aux recommandations.

CE QUI EST CONFIRMÉ

Selon le résumé du rapport, l'exposition aux aGLP-1 suivis par l'enquête est estimée à 840 827 patients-années entre le 1er février 2025 et le 31 janvier 2026. Sur la même période, 2 801 cas d'effets indésirables ont été signalés en France, dont 515 cas graves, parmi lesquels 13 décès. 1 cas sur 3 concernait un traitement du diabète de type 2 et 1 cas sur 3 un traitement pour le contrôle du poids.

Les troubles gastro-intestinaux restent les effets indésirables les plus fréquents : nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales. Des pancréatites, effet indésirable connu, ont de nouveau été déclarées. Parmi les 13 décès, le résumé du rapport juge le rôle de l'aGLP-1 possible dans 2 pancréatites aiguës mortelles et dans 1 cancer du pancréas, classé comme risque potentiel important dans le plan de gestion des risques du sémaglutide.

Le rapport recense 36 signalements d'effets indésirables liés à une utilisation non appropriée pour perte de poids, dont 17 cas graves. Dans plus de 9 cas sur 10, les doses étaient trop élevées ou augmentées trop rapidement. Dans 2 cas sur 3, le médicament avait été obtenu en dehors des circuits officiels. Parmi les cas graves, 5 pancréatites aiguës sont comptabilisées.

Des cas de carences nutritionnelles et de malnutrition ont été déclarés. Le rapport met en évidence un risque d'interaction avec les médicaments à marge thérapeutique étroite, dont la dose doit être ajustée avec précision, comme certains anticoagulants. Chez certains patients diabétiques traités par metformine, les aGLP-1 pourraient majorer le risque d'acidose lactique, notamment en cas de déshydratation liée à des vomissements. 2 décès déclarés sur la période pourraient être liés à ce mécanisme ; le résumé du rapport y retient un rôle indirect de l'aGLP-1.

L'ANSM rappelle que la prise d'aGLP-1 pendant la grossesse n'est pas recommandée, et qu'un traitement en cours doit être arrêté dès qu'une grossesse est connue.

CE QUI POSE QUESTION

Au 13 octobre 2026, 2 questions restent ouvertes. Les aGLP-1 sont-ils en cause dans les atteintes ophtalmologiques, les infections ou inflammations de la vésicule biliaire, les atteintes hépatiques, les atteintes cérébrovasculaires et les troubles de l'érection déclarés ? Le rapport ne confirme pas ce lien de causalité, qui fait l'objet d'une évaluation nationale et européenne.

Les aGLP-1 diminuent-ils l'efficacité des contraceptifs ? L'Agence européenne des médicaments évalue ce risque, après des déclarations de grossesses non désirées.

L'IMPACT FINANCIER & ORGANISATIONNEL

Le communiqué n'aborde pas de conséquence financière directe pour le cabinet. Sur le plan organisationnel, les médecins doivent informer leurs patients des symptômes caractéristiques de la pancréatite aiguë. L'ANSM rappelle qu'un suivi régulier peut permettre de repérer tôt les signes d'effets indésirables graves, et appelle à la vigilance sur les interactions avec les médicaments à marge thérapeutique étroite, comme certains anticoagulants.

LE REGARD DU CERCLE

Le rapport ne remet pas en cause la prescription des aGLP-1 dans leurs indications. Il rappelle que le détournement pour perte de poids et l'achat hors pharmacie exposent à des risques évitables. La médecine générale est en première ligne pour repérer un mésusage, interroger l'origine du médicament et adapter le suivi.

RECOMMANDATIONS

- **Médecin qui prescrit ou renouvelle un aGLP-1** : Informer le patient des signes de pancréatite aiguë, et vérifier à chaque renouvellement les interactions avec les médicaments à marge thérapeutique étroite, comme certains anticoagulants.
- **Médecin qui repère une prise d'aGLP-1 pour maigrir hors indication** : Demander l'origine du médicament et la dose prise, puis déclarer tout effet indésirable au centre régional de pharmacovigilance.

Sources

ANSM, 3e rapport de pharmacovigilance sur les aGLP-1 : persistance du mésusage associé à des complications graves et mise en évidence du risque d'interactions médicamenteuses (7 octobre 2026)

ANSM, résumé du 3e rapport de l'enquête de pharmacovigilance sur les aGLP-1 (octobre 2026)

Traçabilité : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)

Ocrevus (sclérose en plaques) : risque hépatique grave, bilan avant le traitement et la 2e perfusion

SITUATION

Un risque nouveau d'atteinte hépatique d'origine médicamenteuse est identifié sous Ocrevus, avec des cas graves qui ont mis en jeu le pronostic vital.

L'ANSM a publié le 8 octobre 2026 une information de sécurité et le courrier du laboratoire Roche aux professionnels de santé. Il s'adresse aux neurologues, neuropédiatres, hépato-gastroentérologues et médecins généralistes.

CONTEXTE

Ocrevus (ocrélizumab) est un anticorps anti-CD20 utilisé dans la sclérose en plaques. En perfusion intraveineuse, sa dose initiale est administrée en 2 perfusions de 300 mg, la 2e au 14e jour ; une forme sous-cutanée existe aussi. L'exposition depuis la commercialisation dépasse 1,4 million de patients-années.

CE QUI EST CONFIRMÉ

Des cas graves d'atteinte hépatique d'origine médicamenteuse, dont certains ont mis en jeu le pronostic vital, ont été rapportés, avec une élévation marquée des aminotransférases et de la bilirubine totale. La fréquence de cet effet indésirable est indéterminée. Les symptômes sont généralement apparus dans le mois suivant la 1re dose, avant ou après la 2e perfusion de 300 mg au 14e jour.

Un bilan de la fonction hépatique est requis avant l'instauration d'Ocrevus, puis, en perfusion intraveineuse, avant la 2e perfusion de la dose initiale de 300 mg. Pendant le traitement, les patients doivent être informés des signes d'atteinte hépatique : fatigue nouvelle ou aggravée, perte d'appétit, nausées, vomissements, gêne dans la partie supérieure droite de l'abdomen, urines foncées, jaunisse. Un bilan hépatique doit être fait rapidement chez tout patient qui signale ces symptômes, et le patient comme ses aidants doivent consulter immédiatement un médecin en cas de signes évocateurs.

Si l'atteinte hépatique est confirmée, Ocrevus doit être interrompu ; il ne peut être repris que si une autre cause plausible explique les signes. Le résumé des caractéristiques du produit et la notice vont être complétés. Tout effet indésirable suspecté doit être déclaré au centre régional de pharmacovigilance ou sur signalement.social-sante.gouv.fr.

CE QUI POSE QUESTION

Au 13 octobre 2026, 2 questions restent ouvertes. Quel calendrier de surveillance pour la forme sous-cutanée ? Le bilan avant l'instauration vaut pour tous les patients, mais le contrôle avant la 2e perfusion ne concerne que la forme intraveineuse, et le courrier ne prévoit pas d'équivalent pour la forme sous-cutanée.

Combien de cas ont été rapportés, et faut-il surveiller le foie au-delà de la 2e perfusion chez un patient sans symptôme ? Le courrier ne donne pas le nombre de cas et ne prévoit pas de bilan systématique ensuite, seulement un bilan rapide en cas de symptômes.

L'IMPACT FINANCIER & ORGANISATIONNEL

Aucun impact financier n'est annoncé pour le cabinet. Les bilans requis s'inscrivent dans le schéma de traitement suivi par le neurologue. Mais un patient sous Ocrevus qui consulte son généraliste pour une fatigue, des nausées ou une jaunisse doit avoir un bilan hépatique rapide, à tout moment du traitement, et plus encore dans le mois qui suit la 1re dose, où les symptômes sont généralement apparus.

LE REGARD DU CERCLE

Le neurologue pilote le traitement, mais c'est souvent le généraliste que le patient appelle quand il se sent mal entre 2 perfusions. Les signes décrits sont banals et faciles à attribuer à la perfusion ou à la maladie. Chez un patient sous Ocrevus, une fatigue nouvelle ou des nausées justifient un bilan hépatique, à tout moment du traitement, et surtout dans le mois qui suit la 1re dose.

RECOMMANDATIONS

- **Médecin traitant d'un patient qui débute Ocrevus** : Vérifier qu'un bilan hépatique a été fait avant le traitement et avant la 2e perfusion de 300 mg, et expliquer au patient les signes qui doivent le faire consulter.
- **Médecin consulté pour fatigue, nausées, urines foncées ou jaunisse chez un patient sous Ocrevus** : Prescrire rapidement un bilan hépatique et, si l'atteinte se confirme, prévenir le neurologue pour interrompre le traitement.

Sources

ANSM, Ocrevus (ocrélizumab) : risque nouveau d'atteinte hépatique d'origine médicamenteuse et recommandations sur la surveillance hépatique avant et pendant le traitement (8 octobre 2026)

Courrier du laboratoire Roche aux professionnels de santé sur Ocrevus (octobre 2026, publié par l'ANSM le 8 octobre 2026)

Traçabilité : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)